

表 37 ECMO 每日检查记录单 (D)

姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____岁	床	____床	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV
上机时间	____月____日____时	已运行	____天____小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
D 模块：实验室与参数（参照当日最新结果）					
项目	目标范围		今日值		预警阈值 → 处理
APTT	50-80s（无出血）,40-50s(有出血)		_____ s		<40s→血栓风险,上调肝素>100s→出血风险,下调/停肝素
ACT	160-200s(无出血),130-160s(有出血)		_____ s		同上
抗 Xa（如有）	0.3-0.5 IU/mL		_____ IU/mL		>0.7→出血高风险；<0.2→血栓风险
肝素剂量	—		_____ U/kg/h		根据 APTT/ACT/抗 Xa 调整
膜后血气（氧合器出口）	PaO□ 200-400mmHg		pH_____ PaO□_____ PaCO□_____		PaO□<150→氧合器功能下降
患者动脉血气	PaO□80-150mmHg,PaCO□35-45mmHg		pH_____ PaO□_____ PaCO□_____		PaO□<70→提高 ECMO 流量/FiO□;PaO□>300→警惕高氧损伤(VA/ECPR 尤其)PaCO□ 变化过快→脑血流风险
血红蛋白（Hb）	≥8g/dL		_____ g/dL		<7→输血（参照 ELSO 输血阈值）
血小板（PLT）	> 50-80 ×10 ⁹ /L		_____ ×10 ⁹ /L		<50→出血风险高,考虑输注;<20→严重风险
纤维蛋白原（FIB）	> 1.5-2.0g/L		_____ g/L		<1.5→补充纤维蛋白原/冷沉淀
D-二聚体	关注趋势		_____ mg/L		持续升高→环路凝血/血栓形成风险
乳酸	动态下降		_____ mmol/L		>4 或持续不降/升高→灌注不足/病情恶化
血浆游离 Hb（如有）	<50mg/dL		_____ mg/dL		>50→溶血；排查泵头血栓/负压过大
血糖	144-180mg/Dl, (8-10 mmol/L)		_____ mmol/L		<3.9 或>10→胰岛素调整
核心体温	33-36°C(ECPR 亚低温)，常温:<37.7°C		_____ □		>37.7→积极降温（发热增加脑氧耗）

依据：ELSO 指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）。

用途：每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施